



PHQ-9 — Patient Health Questionnaire

RASTREAMENTO E GRAVIDADE DE SINTOMAS DEPRESSIVOS · ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Paciente _____ Data _____

Avaliador _____

Aplicação: ☐ Autoaplicado ☐ Entrevista

Nas últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado(a) pelos problemas abaixo?

Item / sintoma	0 Nenhuma vez	1 Vários dias	2 > metade dos dias	3 Quase todos os dias
1. Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas.	☐	☐	☐	☐
2. Sentir-se para baixo, deprimido(a) ou sem esperança.	☐	☐	☐	☐
3. Dificuldade para dormir, permanecer dormindo ou dormir demais.	☐	☐	☐	☐
4. Sentir-se cansado(a) ou com pouca energia.	☐	☐	☐	☐
5. Falta de apetite ou comer em excesso.	☐	☐	☐	☐
6. Sentir-se mal consigo mesmo(a), como se tivesse fracassado ou decepcionado a si/família.	☐	☐	☐	☐
7. Dificuldade para se concentrar, por exemplo ao ler ou assistir televisão.	☐	☐	☐	☐
8. Lentidão perceptível para se mover/falar ou, ao contrário, inquietação e movimentação acima do habitual.	☐	☐	☐	☐
9. Pensamentos de que seria melhor estar morto(a) ou de se ferir de alguma forma.	☐	☐	☐	☐

IMPACTO FUNCIONAL

Se você marcou algum problema, quanto esses sintomas dificultaram seu trabalho, tarefas de casa ou convivência com outras pessoas?

☐ Nenhuma dificuldade ☐ Alguma ☐ Muita ☐ Extrema

ESCORE TOTAL

/ 27



Resultado e interpretação

Escore total	Gravidade dos sintomas
0 – 4	Mínima / ausente
5 – 9	Leve
10 – 14	Moderada
15 – 19	Moderadamente grave
20 – 27	Grave

RESULTADO DO PACIENTE

Escore _____ Classificação _____

Impacto funcional: ☐ Nenhum ☐ Algum ☐ Muito ☐ Extremo

Atenção ao item 9. Qualquer resposta diferente de “nenhuma vez” requer avaliação clínica específica e imediata da segurança, incluindo natureza dos pensamentos, intenção, plano, meios disponíveis, fatores protetores e necessidade de intervenção. O escore total do PHQ-9 não substitui essa avaliação.

Interpretação clínica

O PHQ-9 é um instrumento de rastreamento e medida de gravidade. Um escore ≥ 10 apresentou sensibilidade e especificidade de aproximadamente 88% para depressão maior no estudo de validação original, mas o diagnóstico deve ser confirmado clinicamente. Avalie também duração, prejuízo funcional, diagnóstico diferencial, transtorno bipolar, substâncias e medicamentos e condições clínicas associadas.

IMPRESSÃO / CONDUTA

- ☐ Sem sintomas clinicamente relevantes ☐ Sintomas leves
☐ Avaliação diagnóstica indicada ☐ Acompanhamento / repetir PHQ-9
☐ Plano terapêutico ☐ Avaliação de segurança realizada

Observações

Dr. Pedro H. Dias Lino

Médico | CRM-7618 | RQE-4251

Referência: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606–613.